

CAPÍTULO 12.3

Trastornos del Sueño

PERFIL EUNACOM 1.10.1.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Trastornos del Sueño

Insomnio

TABLA 12.3.1: TIPO VS DEFINICIÓN	
TIPO	DEFINICIÓN
De conciliación	No puede quedarse dormido
De mantención	Se despierta en la mitad de la noche
De despertar precoz	Se despierta demasiado temprano

Tratamiento

- **Primera línea (siempre):** higiene del sueño + **terapia cognitivo-conductual (TCC)**
- **Fármacos** (solo si insomnio grave, refractario; por breve tiempo, máx 2 semanas):

TABLA 12.3.2: FÁRMACO VS VENTAJA		
FÁRMACO	VENTAJA	INDICACIÓN
Hipnóticos Z (zolpidem, zopiclona, eszopiclona)	Menos efectos adversos	Elección en adulto mayor
Benzodiazepinas (diazepam, clonazepam, alprazolam)	Eficaces	Adulto joven; riesgo de dependencia
Melatonina	Sin efectos adversos	Jet lag / alteración del ciclo circadiano

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Benzodiazepinas: riesgo de adicción → indicar el menor tiempo posible. En adulto mayor → preferir hipnóticos Z.

Hipersomnia

- Necesidad de dormir > 11 horas / día
- **Secundaria** (más frecuente): SAHOS → tratar causa
- **Primaria (idiopática):** estimulantes → metilfenidato, modafinilo, cafeína

Narcolepsia — Tétrada

- **Hipersomnia diurna irresistible** (ataques de sueño — más importante, puede ser el único síntoma)
- **Cataplejía** (pérdida súbita de tono muscular con emociones)
- **Parálisis del sueño** (se despierta consciente pero sin poder moverse)
- **Alucinaciones hipnagógicas** (al quedarse dormido) / **hipnopómpicas** (al despertar)

NOTA CLÍNICA

La parálisis del sueño y las alucinaciones aisladas son normales en la población general. Solo son patológicas en contexto de narcolepsia.

Síndrome de Piernas Inquietas

- Disestesias + movimientos involuntarios de piernas al dormir → se despierta
- **Diagnóstico:** clínico (a veces la pareja lo nota antes)

- **Tratamiento:** hierro (↑ferritina) + agonistas dopaminérgicos (pramipexol, ropinirol)

Pesadilla vs. Terror Nocturno

TABLA 12.3.3: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	PESADILLA	TERROR NOCTURNO
Sueño	REM	No REM
Se despierta	Sí, recuerda el sueño	Sí, grita — no recuerda al día siguiente
Más frecuente en	Cualquier edad	Niños

| Conducta | Manejar estrés, educar | **Educar a los padres** (es normal) |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 82 años consulta por insomnio de conciliación severo, refractario a medidas de higiene del sueño por varias semanas. ¿Cuál es el fármaco más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Trastornos del Sueño. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Insomnio: tratamiento fundamental es higiene del sueño + terapia cognitivo-conductual. Fármacos solo en casos graves, refractarios y por breve tiempo.
- Hipnóticos Z (zopiclona, zolpidem, eszopiclona) son de elección en adulto mayor por tener menos efectos adversos que las benzodiazepinas.
- Benzodiazepinas: riesgo de adicción importante. Diazepam (vida media larga) para insomnio de mantención; alprazolam, midazolam, clonazepam (vida media corta) para insomnio de conciliación.
- Melatonina: pocos efectos adversos pero menos eficaz. Útil en alteraciones del ciclo circadiano (jet lag, azafatas).
- Hipersomnia secundaria (la más frecuente, ej. SAHOS): tratar la causa. Primaria: metilfenidato, cafeína o modafinilo.
- Síndrome de piernas inquietas: diagnóstico clínico. Tratamiento con hierro + prodopaminérgicos (pramipexol, ropinirol).
- Pesadillas (REM, se recuerdan) vs terror nocturno (no-REM, no se recuerda). Ambos normales, manejo: educación y manejo del estrés.
- Narcolepsia: hipersomnolencia diurna irresistible es el síntoma más importante y puede ser el único. Cataplejía, parálisis del sueño y alucinaciones hipnagógicas/hipnopómpicas completan la tétrada.
- Parálisis del sueño y alucinaciones hipnagógicas/hipnopómpicas aisladas son NORMALES. Conducta: educar y tranquilizar.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRASTORNOS DEL SUEÑO)**PREGUNTA 1**

Paciente de 82 años consulta por insomnio de conciliación severo, refractario a medidas de higiene del sueño por varias semanas. ¿Cuál es el fármaco más adecuado?

- A)** Diazepam
- B)** Amitriptilina
- C)** Zolpidem
- D)** Alprazolam
- E)** Clonazepam

PREGUNTA 2

Paciente de 35 años presenta ataques de sueño irresistibles durante el día desde hace 6 meses, a pesar de dormir bien en la noche. Además refiere episodios en que pierde el tono muscular estando despierto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Síndrome de apnea obstructiva del sueño
- B)** Hipersomnia idiopática
- C)** Narcolepsia
- D)** Epilepsia tipo ausencia
- E)** Síndrome de piernas inquietas

PREGUNTA 3

Madre consulta preocupada porque su hijo de 5 años se levanta gritando y llorando durante la noche, pero al día siguiente no recuerda nada. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Solicitar electroencefalograma para descartar epilepsia
- B)** Iniciar benzodiazepinas en dosis bajas
- C)** Derivar a psiquiatría infantil
- D)** Educar a los padres: es un terror nocturno, es normal y manejar el estrés
- E)** Solicitar polisomnografía

RESUMEN: TRASTORNOS DEL SUEÑO

Esta clase cubre los principales trastornos del sueño: insomnio, hipersomnia, síndrome de piernas inquietas, pesadillas y terrores nocturnos, y narcolepsia. El insomnio se define como dificultad para conciliar el sueño (de conciliación) o para mantenerlo (de mantención/despertar precoz). El tratamiento fundamental es la higiene del sueño y terapia cognitivo-conductual; los fármacos solo se indican en casos graves, refractarios y por breve tiempo. Los fármacos para el insomnio incluyen benzodiazepinas (alprazolam, clonazepam, diazepam, midazolam) con riesgo de adicción, y los hipnóticos Z (zopiclona, zolpidem, eszopiclona) que tienen menos efectos adversos y son de elección en el adulto mayor. La melatonina es más natural pero menos eficaz, útil en alteraciones del ciclo circadiano. La hipersomnia (necesidad de dormir más de 11 horas/día) puede ser secundaria (SAHOS, lo más frecuente) o primaria/idiopática (tratamiento con metilfenidato, cafeína o modafinilo). El síndrome de piernas inquietas se caracteriza por disestesias y movimientos de piernas al dormir, tratándose con hierro y prodopaminérgicos (pramipexol, ropinirol). Las pesadillas (sueño REM, se recuerdan) y terrores nocturnos (sueño no-REM, no se recuerdan) son normales; el manejo es educación y manejo del estrés. La narcolepsia presenta una tétrada: hipersomnolencia diurna irresistible (el más importante, puede ser el único), cataplejía, parálisis del sueño, y alucinaciones hipnagógicas/hipnopómpicas. Los puntos 3 y 4 pueden ser normales de forma aislada.